

31 - 05- LES ICTÈRES NÉONATALS - Pr. MAOULAININE

Chers étudiants, bonjour. On va voir un autre quatrième cours de la néonatalogie. C'est les ictères néonatales.

C'est quoi l'ictère ? L'ictère, c'est une coloration jaunâtre des téguments. C'est un motif fréquent de consultation. Pour cela, les objectifs de ce cours doivent être maîtrisés.

L'étudiant doit faire une démarche diagnostique devant un ictère néonatal à partir du dosage de la bilirubine et le contexte clinique. Il doit décrire les caractéristiques d'un ictère pathologique par rapport à un ictère physiologique. Il doit connaître les principales étiologies du ictère à bilirubine directe et à bilirubine indirecte.

Il doit connaître le traitement symptomatique d'un ictère néonatal. On a dit que le ictère, c'est une coloration jaune. C'est un symptôme qui peut être rapporté par la maman, ou bien rapporté par le papa, ou bien rapporté par l'infirmier, ou bien par la sage-femme.

Une coloration jaune correspond à un taux de la bilirubine qui est supérieur à 50 à 70 micromoles par litre. A peu près 10 à 30 % des nouveaux-nés à terme présentent un ictère. Il est plus fréquent chez les nouveaux-nés prématurés par rapport aux nouveaux-nés à terme.

La majorité des ictères, ils sont à bilirubine non conjuguée, ou bien à bilirubine libre. Mais ce qui est dangereux, deux choses. C'est la teinte du cerveau et la teinte du fond.

Si on a une bilirubine non conjuguée, ou bien directe, qui est augmentée, qui est importante, il y a un risque nucléaire. Ça veut dire qu'il y a un risque d'atteinte des noyaux gris centraux. On appelle ça une encéphalopathie hyperbilirubinique.

Il y a un risque aussi de surdité, il y a un risque d'atteinte de la voie auditive. Et le seuil qu'on doit vraiment faire attention, c'est le supérieur à 350 micromoles par litre chez le nouveau-né. On s'assure qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent aggraver le risque d'une atteinte neurotoxique.

On va voir ça plus loin. L'ictère à bilirubine libre peut révéler un conflit auto-immune. Plus souvent, un conflit auto-immune.

Plus souvent, une incompatibilité de nos systèmes rigides, ou bien dans l'isocope. Deuxième risque d'atteinte, c'est le froid. C'est la cirrhose hépatique.

C'est en rapport avec un ictère à bilirubine conjuguée. L'étiologie la plus fréquente qu'il faut craindre, c'est la trisidivose biliaire extra-hépatique. On va voir un rappel physiologique.

La bilirubine provient de la dégradation de l'hémoglobine au niveau des organes hématopoïétiques, au niveau de la moelle, au niveau de la vête, au niveau du foie. Elle va produire la bilirubine issue de la dégradation de l'hémoglobine. Et puis elle va donner la bilirubine qui va circuler dans le sang, soit liée à l'albumine, soit elle est seule.

Et s'il y a une fraction qui est très importante, elle peut passer par la barrière hémato-méningée, et c'est aussi là qu'il y a une voie pour l'albumine. Elle va être transportée par l'albumine au niveau du foie et là-bas, elle sera conjuguée en bilirubine conjuguée grâce à la glycoronine transpirase. Et puis elle va donner la zircobilinogène qui va donner la coloration jaunâtre-lissaine, et l'érobilinogène qui va donner la coloration jaunâtre-disurée.

Quelles sont les seules contraintes de diagnostic ? Le plus souvent, la maman constate une coloration jaunâtre, donc le plus souvent des conjonctives. Soit l'infirmière ou bien l'infirmier va constater ça, soit le médecin, soit la femme. Parfois, la maman va changer les couches, il va trouver une coloration anormal-dissaine, planchâtre, avec une discrète coloration jaunâtre d'éthiquement.

C'est donc la néctar qui est polystatique. Le syndrome hémorragique peut révéler néctar, parce que si on a une conrystase, parfois on a une hypovitaminose K, et ça peut donner un risque d'hémorragie digestive, des hématèmes, rectoragés, méléna, secondaire à une diminution du facteur vitamine K dépendant de la coloration. Parfois, les convulsions peuvent être le premier signe qui nous oriente vers un néctar, parce que le nouveau-né, soit il a une infection, soit il a une atteinte neurologique en rapport avec un ton important de la bilirubine libre.

Parfois, la fièvre, qui peut être en premier, la maman vient consulter, on va examiner le nouveau-né, on va trouver une coloration jaunâtre en néctar. Parfois, c'est au moment de la vaccination que les parents sont informés que leur bébé, il a une coloration jaunâtre, donc il a un néctar, et c'est un moment important pour faire le diagnostic précoce, pour ne pas passer à côté d'un néctar pathologique. Comment confirmer le diagnostic ? Bien sûr, c'est un symptôme, c'est une coloration, mais on a ce qu'on appelle le bilirubinomètre transcutanique qui peut nous renseigner sur l'autosanguin d'une manière indirecte de la bilirubine.

Et bien sûr, le dosage de sanguin de la bilirubine totale conjuguée libre qui va nous orienter vers l'augmentation d'autos de la bilirubine. Pour l'appareil de bilirubinomètre transcutané, le principe de base de fonctionnement, c'est une spectrophotométrie. C'est un instrument non-invasif, pas de fonction veineuse.

Deux types de bilirubinomètre. Chez les nouveaux-nés qui ont un âge d'exclusion supérieure à 36, on utilise le biliflash. Et chez les nouveaux-nés dans l'âge d'exclusion supérieure à 32 semaines, avec un poids supérieur à 1,5 kg, on utilise le bilicheck.

Sachant que même si on utilise la bilirubinomètre transcutanée, il faut faire une photo qui montre à une infirmière qui est en train de réaliser un examen par le bilirubinomètre transcutané. Ce sont les facteurs de majoration du risque d'hyperbilirubinémie sévère. Lorsqu'on parle d'hyperbilirubinémie sévère, ça veut dire qu'il y a une atteinte neurologique, un lecteur avec retentissement neurologique, avec une atteinte du noyau gris central.

Si on a un âge inférieur à 38 semaines, s'il y a un niftel qui est précoce, si on a une incompatibilité dans le système rigeuse, ou bien dans le système ABO, ou bien dans les sous-

groupes. En cas de présence d'agglutines irréguliers dans le dernier trimestre de la grossesse, la maman part chez le gynécologue et réalise les prélèvements. Il y a donc des agglutines irréguliers qui sont positives, c'est le troisième trimestre.

S'il y a des antécédents familiaux de maladies hémolytiques, on cite la sphérocytose, mais aussi le déficient GCSPD. Antécédents dictaux traités par la photothérapie dans l'infra-rouge, une bourse séro-sanguine, ou bien des équimoses, ou des hématomes tels un cœlémome. En test, on parle d'un diagnostic de gravité.

On appelle des signes qui font appel, c'est des signes neurologiques. Donc si on a un nouveau-né qui est somnolent, qui a un cri neurologique, qui prend une hyperextension de la tête, s'il a l'opistotonose, s'il a des convulsions, ce sont des signes de gravité. S'il a une asphyxie prénatale, on a dit que le diagnostic d'une asphyxie prénatale, ou bien de la souffrance prénatale, c'est en rapport avec une diminution de la perfusion du fœtus et peut être secondaire à des anomalies qui sont anatomiques, ou bien une infection, ou bien en rapport avec l'hypertension artérielle chez la maman, c'est la prééclampsie.

Il peut se manifester par une bradycardie avec un rythme plat et des décélérations tardives sur l'enregistrement de tocographes qui va enregistrer les contractions utérines de la maman et la fréquence cardiaque du fœtus. Si on a une instabilité thermique, ça veut dire qu'il fait des hypothermies, il fait de la fièvre, ça veut dire que le centre neurologique de régulation n'est pas bien fonctionnel. S'il y a une infection, il majore le risque d'atteinte neurologique de la bilirubine si on a une anémie, une anémie hépatique et s'il y a une hémorragie cérébrale.

On a vu comment on peut faire le diagnostic, il faut faire le dosage, quels sont les facteurs de gravité, maintenant on va voir quels sont les éléments qui vont nous orienter vers une chirurgie. A l'anténatal, il faut demander le groupage de la maman, s'il est haut, s'il résiste à la maman, s'il est négatif, parfois il faudra demander du père, combien de grossesses la maman a, quel est le groupe sanguin des enfants, de la fratrie, est-ce qu'il y a une notion de fausse couche ou bien de transfusion sanguine antérieure, parce que si on ne connaît pas le groupage de la maman, elle a été transfusée par le résiste positif et elle a un résiste négatif, donc il y a un risque de développer des anticorps qui peuvent passer par la voie hématologique, transplacentaire, et peuvent causer une dyslexie du globe, une rougeur et le fœtus, ou bien chez le nouveau-né après sa naissance et donner un néonate. Poser la question, est-ce que la maman a reçu une prolapsie antérieure anti-D, c'est-à-dire la maman qui a un résiste négatif et on réalise le groupage du nouveau-né après la naissance et le groupage du nouveau-né est positif et on doit injecter systématiquement le sérum anti-D pour empêcher la synthèse des anticorps contre le résiste positif.

Est-ce que la maman avait des signes anamnétiques d'une infection ? Est-ce qu'elle avait une pyropathie ? Est-ce qu'elle avait une notion de souffrance ? Est-ce que le nouveau-né est prématuré ? Quelle est l'heure post-natale d'apparition ? Tout en sachant que toutes les néonates qui apparaissent dans les 48 heures devaient être des néonates pathologiques. La

coloration des isolines et des cils, donc si les cils sont décolorés ou bien peu colorés, ça oriente vers une cholestase. S'il y a des isolines qui sont foncées, c'est probablement en rapport avec la cholestase.

Le type d'alimentation ici, donc on cherche s'il y a une alimentation par le lait maternel ou bien le lait artificiel, tout en sachant que rarement le lait maternel est responsable d'un nectar. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic anti-natal, donc dans l'anamnèse, nous parlons maintenant d'une repatie malformative, on a vu ça dans le cours, on dit que pour prévenir l'infection, l'infection urinaire à HH acolyte peut donner un nectar. À l'examen clinique, il semble ici qu'ils vont nous orienter vers une lithologie.

Bien sûr, ce n'est pas l'intensité de l'nectar, parce que l'intensité de nectar, c'est très intéressant, on dit que probablement c'est un nectar qui est grave et on va voir les plantes du pied et du paon des mains, c'est sangeant, ça veut dire que c'est un nectar qui est intense. Si on a une décoloration du sel et des urines qui se sont enfoncées, ça, c'est en faveur d'une cholestas. Si on a de la fièvre, purpérame, herbure, épithermie, probablement il y a une infection et dans les infections, on peut voir les deux nectars, c'est un nectar mix, un nectar avélérubine libre et un nectar avélérubine conjugué.

Parfois, le plus souvent, c'est un nectar avélérubine libre. L'hépatomie galée, l'aspiromie galée, peut nous orienter vers une lithologie hémolytique, soit une infection, soit une incompatibilité dans le système rhesus ou bien dans le système ABO, ou bien dans les sous-groupes. Si on a une dysmorphie faciale, ça peut nous orienter vers une lithologie, ce qui est le syndrome de l'agile.

Si on a une macroglossation, c'est probablement une épithéroïdie. Parfois, on fait un examen et on oublie de palper la tête et le diagnostic, parfois, c'est uniquement en rapport avec une poussière sanguine ou bien un cyfre lumato. Pour s'orienter vers l'ithiologie, il faut demander, premier examen, par alcalinique, à demander en cas d'ictale, c'est le usage de l'abélérubine totale conjuguée.

Pourquoi ? Parce qu'il y a des ithiologies qui sont propres à l'ictale abélérubine libre et il y a des ithologies qui sont propres à l'ictale abélérubine conjuguée. Nous devons demander une numération sanguine à la recherche d'autodémoglobine qui va nous orienter vers une hémorrise. Les leukocytes se sont augmentés et les plaques se sont diminuées avec une augmentation du PNN neutrophile.

Ça oriente vers une infection. Il faut faire un test de CAMPS direct chez le nouveau-né et un test direct chez la maman direct chez le nouveau-né à la recherche d'une réaction immunologique. S'il est positif, ça veut dire que probablement il a une incompatibilité soit dans le système rhesus ou bien dans le système sogrope.

Il faut faire un groupage du nouveau-né et de la maman avec le rhesus. Parfois, on peut faire à nous orienter vers une infection urinaire. L'ACRP est demandé pour chercher la probabilité

d'une infection à niveau natal précoce ou bien une infection urinaire chez le nouveau-né qui peut donner un... Bien sûr, on demande le dosage de la bilirubine et il y a des courbes qui orientent vers un tout-kit très important soit en rapport avec l'âge post-natal et l'âge gestationnel.

Parfois, c'est aussi avec le poids du nouveau-né. Quelles sont les idéologies ? Dans la majorité des cas, ce sont les incompatibilités ou bien dans les actes hémolithiques à bilirubine libre. L'incompatibilité, c'est le chef de fil.

Dans le système rhesus, le nouveau-né a un rhesus positif et la maman a un rhesus négatif. Le sysocompe, le plus souvent, il est positif et ça témoigne que la maman a des anticorps d'antibité qui ont frangé la barrière et qui ont distribué après la naissance ou bien parfois même avant la naissance les globules rouges du nouveau-né. Deuxième idéologie des actes hémolithiques à bilirubine libre, l'incompatibilité au groupe rhesus.

Troisième idéologie, c'est l'incompatibilité dans le système O, A, B. Ça veut dire que la maman est O, le bébé est de groupe A ou bien de groupe B. L'hémolithe, il est moins marqué mais parfois il est précoce et parfois il est tardif. Dans la l'immunisation anti-D, on a dit que la bilirubine libre est augmentée. Sur la physiopathologie, si la maman est synthèse des anticorps contre l'immunisation vitale, parce qu'il y a franchement une immunisation et les anticorps sont les EGG, ils vont partir à travers la perfusion placentaire et détruire les imacies du nouveau-né, qui a donc un rhesus qui est positif.

Le diagnostic anti-natal, on peut parfois le réaliser avec la myosynthèse et avec l'existence d'un état de NASAC avec une anémie vitale. Les post-natal, on fait lesquels grâce à la présence d'un nectaire avec une anémie. On peut faire un diagnostic anti-natal basé sur l'anamnèse, le groupage de la maman avec les ER et les médecins qui sont positifs.

Parfois, s'ils sont positifs, il faut faire une surveillance écologulaire à la recherche d'une anémie vitale. On peut faire un gynécologue ou l'oxytrécien peut faire une échographie avec l'échodoplate des artères cérébrales. Il y a des logiciels qui disent qu'en fonction de la perfusion, on peut susciter une anémie vitale.

Si il y a une anémie, c'est probablement c'est un rapport avec une hémorrhèse anti-natale qui peut commencer en intra-hétero et on peut faire des transfusions dans les grands centres de l'immatologie. Pour vous dire tout simplement que si on a une maman qui a un registre négatif, on doit faire systématiquement le groupage du nouveau-né après la naissance. Si elle a un registre positif, nous devons administrer les immunoglobulins anti-D avant H62, 72 heures.

Parfois, si la maman a fait une fausse couche et qu'elle a un groupage de registre négatif, s'il s'agit d'une première part, on injecte systématiquement les immunoglobulins anti-D parce qu'on n'a pas de notion sur le groupage de futur. Si la première cause, l'immunisation de l'ocysteme rhesus, démolise en période innatale, on a parlé de comment faire le diagnostic après la naissance. On fait le groupage de la maman, le groupage du bébé, et bien sûr, la

numération doit trouver l'immoglobulin qui est diminué et le traitement doit être démarré rapidement.

Le plus souvent, c'est la photothérapie avec parfois la transfusion. L'hyxogénotransfusion est rarement indiquée. Dans l'immunisation de l'ocysteme OAB, il y a un nictel abilioribine libre.

La maman a un groupage O, le premier nouveau-né, qui peut présenter un nictel qui est le groupage le plus souvent A, B ou AB. C'est un nictel qui est parfois précoce, mais parfois, il est prolongé. On a dit l'immunisation de l'ocysteme OAB, parfois, il peut se révéler par une anémie tardive chez le nouveau-né.

Le test de Combs, le plus souvent, il est négatif dans 50% des cas. Donc, si on a un nictel avec test de Combs qui est négatif, le groupage, bien sûr, il faut le faire. La maman est O et le nouveau-né est AB ou bien A ou bien B. Pour le traitement du nictel abilioribine libre, c'est en fonction du taux de l'abilioribine totale, ce n'est pas le taux de l'abilioribine seule.

Le niveau de risque faible ou moyen au niveau du nictel nucléaire est défini en fonction de l'âge gestationnel et de l'existence ou non des facteurs aggravants. Quels sont les facteurs aggravants ? C'est l'anémie hémolithique, les signes neurologiques, l'asphyxie pérennale, l'instabilité thermique, l'infection, l'acidose, et l'hypoalbuminémie inférieure à 40 grammes par litre. C'est le courbe qui indique le traitement par la photothérapie intensive ou bien l'exongénothérapie pour les nouveaux-nés qui sont âgés de plus de 35 semaines d'améliorement.

La photothérapie, peut-être une photothérapie intensive ou bien non intensive. L'efficacité par réduction des concentrations de la bilirubine dépend de la surface cutanée exposée, l'action sur le bilirubine non conjuguée à 2 millimètres solipédares, la modification de la bilirubine par la photo-isomérisation structurelle ou l'éminorubine hydrosoluble excrétée dans l'isoline, chute de niveau de la bilirubine plus importante dans la peau que dans le cerneau. La nécessité d'une surveillance régulière de l'intensité et du spectre de la lumière par radiomètre homologue.

Voilà les photos d'une photothérapie conventionnelle à gauche et photothérapie intensive à droite. Parfois, on peut faire l'exongénotransfusion tout en sachant que les objectifs de cette exongénotransfusion c'est upérer la bilirubine, upérer les anticorps maternels, corriger l'anémie. On fait des échanges de 2 masses sanguines à 3 masses sanguines.

L'utilisation du sang total reconstitue un registre négatif ou de groupes compatibles avec la mère et l'enfant. Exceptionnellement, on le réalise en cas d'aluminization des gistes rarement impériaux, en cas d'anémie hémolithique sévère, précoce, ou bien les pertes de la bilirubine qui ne s'améliorent pas sans la photothérapie intensive. Les autres égytes hémolithiques, les difficileurs osématiques du globule rouge, les difficileurs d'insipidité, et les vaticanases.

Il faut faire l'usage avant toute transfusion parce que sinon, on va faire le diagnostic après 3 mois. La microsphérocytose héréditaire c'est une cause des égytes hémolithiques à la bilirubine

libre. La thalassémie et la glépanocytose ce sont des cas qui sont quand même rares en période d'immunité.

L'infection neonatale peut donner un nictel, plus souvent à l'échelle chair-colique, qui peut donner un nictel mix. Cela veut dire que le taux de la bilirubine est augmenté et le taux de la bilirubine congelée est augmenté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réaction croisée entre les anticorps antibactériens, les antigènes électrocytiques du groupe ABO, et parfois, il y a la même localisation au niveau hépatique de l'échelle chair-colique.

Donc, il y a une fragilisation de la membrane desimacie avec l'hémolyse. Les infections virales, ou pas assez rarement, donnent un nictel. On parle d'un nictel prolongé chez un ouvrier à terme si il est supérieur à une semaine.

Au-delà d'une semaine, il a passé son nictel, et s'il est passé au-delà de trois semaines chez un ouvrier prématuré, on parle d'un nictel prolongé. Le plus souvent, l'ithiologie, c'est dans l'incompatible système OA ou bien OB. Marie-Edou Gilbert, l'hypothérapie congénitale, ce sont des ithiologies des nictels néonataux prolongés.

L'nicTEL avérabile congelué et la cholestase extrahépatique. On a vu donc les ithiologies de l'nicTEL non-cholestatique ou bien l'nicTEL avérabile libre. On va voir les ithiologies des nictels cholestatiques.

Malheureusement, dans notre pays, il y a toujours, malheureusement, un retard de 50% parce que les grossesses ne sont pas suivies, l'accouchement parfois est réalisé à domicile, la maman n'arrive pas à faire le diagnostic de l'nicTEL et malheureusement, il vient tardivement avec parfois même des sorties précoces de la maternité. La maman accouche, elle part et ça dépend de la vigilance de la maman pour étiqueter une coloration d'étiquement et venir à l'hôpital pour que son bébé soit examiné. Donc on dit que même en France, il y a un nouveau liste sur 2600 qui présente un nictel.

La grande ithiologie ou bien qu'il ne faut pas passer à côté, c'est la trahison du voie biliaire extrahépatique. Il doit être évoqué en premier en cas de nictel avérabile conjugué. La démarche rigoureuse basée sur la clinique.

En antinatal, il faut demander les sérologies de la maman, torche, toxo, la séphilis, la ribiole, le cytome galovirus, l'herpès. Ce sont des ithiologies du nictel cholestatique. Parfois, c'est la polysplénie qui peut nous orienter vers une trahison du voie biliaire extrahépatique.

A la période neonatal, le nictel est prolongé. Il faut faire un examen clinique à la maternité. Le pédestre doit faire attention à ses sangs décolorés.

S'il y a un disquement facial, un hypotonie, un souffle cardiaque, ce sont des signes qui peuvent rentrer dans un syndrome d'allergie. Parfois, c'est les complications qui révèlent le nictel cholestatique, tel un syndrome hemorrhagique ou bien un con. La trahison du voie biliaire, sur le plan clinique, il n'y a pas grand-chose.

L'état général du foie est plus souvent bien. Il y a une bonne croissance splanchnique. Mais un icterus qui persiste avec des ailes qui sont décolorées, avec des ailes qui s'enfoncent, ça oriente vers une atresie du foie biliaire extra-hépatique.

Les ailes, il faut faire attention. Parfois, elles sont colorées par les urines. Parce que la maman est médo, c'est difficile.

Lorsqu'on voit, on examine un nouveau-né, nous devons profiter voir, examiner même les ailes avec la vislangue. Parfois, on trouve que les urines foncées, elles colorent les ailes qui sont décolorées, qui sont blanches. Rechercher une hépatomie guélie, c'est tardif, c'est un signe tardif.

C'est pour cela qu'il faut faire un diagnostic précoce avant la sixième semaine. Pourquoi? Parce que la complication majeure, c'est la séro-sympathie qui s'est vite installée. C'est foutu pour le foie, c'est la transplantation hépatique comme traitement qui doit être progressé.

Vous voyez donc les ailes qui sont pâles, les ailes qui sont normales et des ailes qui sont blanchâtres. Donc les ailes normales à gauche, les ailes blanchâtres à droite et des ailes qui sont pâles avec des urines qui sont foncées. Il faut penser à la trépidation biliaire extra-hépatique.

Parfois, il y a la trépidation biliaire non syndromique dans 90%, dans 10 à 25%. Parfois, il y a la trépidation biliaire syndromique avec des malformations congénitales digestives et cardiaques associées. On peut trouver une polystémie avec CV, etc.

L'échographie doit être faite à jeun chez le nouveau-né. Ça veut dire au minimum deux heures. Il ne doit pas prendre le repas.

Pourquoi? Parce que il y a des signes qui sont positifs, il y a des signes qui sont négatifs. L'huile du foie est hyper-éthnogene, signe du cône fibreux qui est dans l'huile du foie. Un syndrome de polysplénie, des signes négatifs, absence de vésicules biliaires et de dilatation des voies biliaires.

Parfois, une vésicule biliaire est atrophique. Pourquoi l'échographie est normale? Parfois, malheureusement, c'est en pair opératoire qu'il faut faire le diagnostic. Et parfois, on peut faire une fonction du foie avec une étude anatomopathologique qui peut orienter vers le diagnostic et confirmer le diagnostic de la trahison biliaire tout en sachant que parfois, même avec une fonction biophysio-pathique, s'il y a l'acolestase du cas, s'il n'y a pas d'autre opération qu'il faut faire, c'est le casail.

C'est une hépatopathie antéro-stomacale qui doit être réalisée avant l'âge de 4 semaines, après l'assassinat. En cas de traitement tardif, il y a un risque de séro-sympathie, c'est la transplantation du foie programmé qui doit être réalisée. Il y a certains programmes qui dépistent l'acolestase.

Je parle ici du programme de dépistage de la trahison biliaire en Suisse. Il y a une fiche de carte

cholérémétrique des selles et l'infirmière, ou bien la sage-femme, voit la coloration des selles et compare avec cette carte cholérémétrique. D'autres étiologies de l'acolestase intrahépatique.

On a vu l'acolestase extrahepatique. Chef de file, c'est la trahison du foie biliaire. Parfois, il y a aussi le cas du gliedoc.

Parfois, il y a une lithiase qui peut révéler une acolestase. Dans les étiologies d'acolestase intrahépatique, il y a souvent une phétopathie, donc les ongles de phétopathie, la torche, la toxoplasmose, la syphilis, la ribiole, le système égalovirus et l'herpès. L'infection linéaire postnatale, il y a parfois l'infection bactérielle périlatale.

Il y a certaines enzymopathies et maladies génétiques, tels le syndrome de l'Agile, l'infection alpha-antitrypsine, mycoviscidose, acolestase fibrinogène familial, cytopathie, syndrome de l'immunopique et maladie de Gaucher. Le syndrome de l'Agile, il y a une acolestase avec épaisse cholestérolimie, il y a un fasciste qui est bombé, donc avec l'embryotoxone à l'examen immunologique, des vertèbres qui sont en ailes de papillons avec les coqueurs, une atrésie de l'artère pulmonaire. Parfois, il y a un retard de croissance et parfois, il y a une atteinte rénale tubulaire et ongulomériennaire.

Ça, c'est l'arbre décisionnel d'un nectar. Si on a un nectar, il est soit à bilirubine libre, soit à bilirubine conjuguée. Bilirubine libre, il y a deux voies, soit il y a une hémolyse, soit pas d'hémolyse.

Dans l'hémolyse, il y a des incompatibilités, parfois l'infection, parfois les ennemis hémolytiques concessionnels. L'nectar non-hémolytique, il y a parfois l'infection congénitologique, il y a l'hypothéroïdie congénitale et certaines maladies génétiques. Dans le nectar à bilirubine conjuguée, il y a donc l'acolestase extrahepatique, donc l'atrésie voibiliaire qu'il faut suspecter en premier.

Parfois, il y a une crise de colédoc, la détresse de la voibilia principale. Dans l'acolestase intrahépatique, il y a l'éphétopathie, les torches, l'infection, les hépatites, les enzymopathies, les maladies métaboliques congénitales. En conclusion, il faut distinguer entre le nectar à bilirubine libre et conjugué.

Tout nectar qui est apparu avant H48 chez un nouveau-né est un nectar pathologique jusqu'à preuve du contraire. Il faut faire le dosage de la bilirubine et le reste du bilan doit être orienté et justifié. L'éctate cholestatique, si on a un éctate cholestatique, il y a un risque d'insuffisance hépatique avec coléstase.

Si on a un éctate à bilirubine libre, il y a un risque d'encephalopathie hyperbilirubine avec une technologie qui peut être fixe et définitive, d'où l'intérêt de faire un diagnostic précoce, mais surtout un traitement précoce. Je vous remercie, chers étudiants.